Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AUFKLÄRUNGS- UND EINWILLIGUNGSBOGEN

Tiefes Halslifting

Halsstraffung, bei der auch die tieferen Strukturen des Halses behandelt werden (Deep-Plane-Halslifting)

Liebe Patientin, lieber Patient, dieser Bogen soll Ihnen in **einfacher und verständlicher Sprache** erklären, was Sie über den Ihnen empfohlenen Eingriff wissen sollten. Er soll Ihnen keine Angst machen, sondern Ihnen helfen, Ihre Entscheidung **frei und gut informiert** zu treffen.

Bitte lesen Sie diesen Bogen in Ruhe durch. Fragen Sie Ihren Arzt nach allem, was Sie nicht verstehen. Ihr Arzt wird Ihnen außerdem mündlich die Risiken erläutern, die speziell in Ihrer Situation bestehen. Ob Sie Ihre Einwilligung geben oder nicht, ist allein Ihr Recht.

ANGABEN ZU PATIENT/IN UND EINGRIFF

Vor- und Nachname: _____ Geburtsdatum: _____

Reisepass- / Ausweisnummer: _____ Akten- / Protokollnummer: _____

Telefon: _____ Datum der Aufklärung: _____

Geplantes Datum des Eingriffs: _____

Bogen erstmals an Patient/in übermittelt (Datum / E-Mail, WhatsApp, persönlich): _____

Durchführender und aufklärender Arzt: **Op. Dr. Murat Ayata**

Krankenhaus / Einrichtung, in der der Eingriff durchgeführt wird: _____

Geplante Bestandteile:
☐ Platysmaplastik ☐ Entfernung von tiefem Fett
☐ Verkleinerung des Musculus digastricus
☐ Verkleinerung der Unterkieferspeicheldrüse ☐ Hautentfernung

Gleichzeitiges Facelift: ☐ Nein ☐ Ja (mit gesonderter Einwilligungserklärung) _____

Weitere gleichzeitig durchzuführende Eingriffe: _____

Anliegen und Erwartungen der Patientin/des Patienten: _____

1 Ihre Erkrankung und das Ziel des Eingriffs

Mit dem Alter, durch Gewichtsveränderungen oder aufgrund erblicher Merkmale können sich am Hals eine **Fülle unter dem Kinn**, ein Verlust des Winkels zwischen Kiefer und Hals, **senkrechte Stränge** (Stränge des Platysmamuskels) und **erschlaffte Haut** entwickeln. Dieses Erscheinungsbild wird häufig nicht nur durch Fett unter der Haut verursacht, sondern auch durch **tiefes Fett unter dem Halsmuskel, die Muskeln unter dem Kinn (Musculi digastrici) und ein Absinken der Speicheldrüsen (Unterkieferspeicheldrüsen)**.

Beim tiefen Halslifting werden auch diese tieferen Strukturen behandelt, mit dem Ziel, die Kieferlinie zu konturieren und einen **jüngeren, klarer definierten und natürlich wirkenden** Hals zu erreichen. Das Ergebnis hängt von Ihrer Hautelastizität, Ihrem Knochenbau, Ihrem Gewicht und Ihrem Alter ab. Die Operation hält das Altern nicht auf; der Hals wird mit der Zeit allmählich weiter erschlaffen.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Wie wird der Eingriff durchgeführt?

Die Operation wird in der Regel in Vollnarkose im Operationssaal durchgeführt. Vorher wird Ihr Hals im Sitzen und im Stehen untersucht, fotografiert und angezeichnet, und die zu behandelnden Strukturen werden gemeinsam mit Ihnen festgelegt.

1. **Schnitte:** In der natürlichen Falte unter dem Kinn wird ein Schnitt von etwa 3–5 cm angelegt. Soll überschüssige Haut entfernt werden, kommen Schnitte um das Ohrläppchen hinzu, die hinter dem Ohr in Richtung Haaransatz verlaufen. Die Schnitte werden so weit wie möglich in natürlichen Falten und im behaarten Bereich verborgen.
2. **Ablösen der Haut:** Die Haut des Halses wird behutsam vom darunterliegenden Muskel gelöst; bei Bedarf wird das oberflächliche Fett gleichmäßig ausgedünnt.
3. **Entfernung von tiefem Fett:** Das tiefe Fett unter dem Halsmuskel (Platysma), das durch eine Fettabsaugung von außen nicht erreicht werden kann, wird kontrolliert verringert.
4. **Musculi digastrici und Unterkieferspeicheldrüsen:** Bei Bedarf wird der vordere Anteil des Musculus digastricus, der eine Fülle unter dem Kinn verursacht, ausgedünnt. Ist eine Speicheldrüse (Unterkieferspeicheldrüse) abgesunken und hervortretend, kann der vorstehende Anteil bei Bedarf teilweise verkleinert werden; die Drüse wird nicht vollständig entfernt.
5. **Platysmaplastik:** Die Ränder des Platysmamuskels, die in der Halsmitte auseinandergewichen sind und Stränge bilden, werden miteinander vernäht, sodass ein „inneres Korsett" entsteht; bei Bedarf wird der Muskel zusätzlich seitlich aufgehängt.
6. **Entfernung überschüssiger Haut und Wundverschluss:** Die Haut wird spannungsfrei nach oben und hinten verlagert, und der Überschuss wird entfernt. Blutungen werden sorgfältig gestillt, meist wird eine **Drainage** (ein dünner Schlauch zum Ableiten von Flüssigkeit) eingelegt, die Schnitte werden mit feinen Nähten verschlossen und ein Halsverband wird angelegt.

Die geplanten Bestandteile sind von Person zu Person unterschiedlich; nicht jeder Schritt wird bei jeder Patientin bzw. jedem Patienten durchgeführt. Soll gleichzeitig ein Facelift durchgeführt werden, wird dafür eine **gesonderte Einwilligungserklärung** unterschrieben.

BETÄUBUNG (ANÄSTHESIE)	VORAUSSICHTLICHE DAUER	KRANKENHAUSAUFENTHALT / ENTLASSUNG
Vollnarkose (bei ausgewählten Patienten Sedierung + örtliche Betäubung)	Etwa 2–4 Stunden (bei kombinierten Eingriffen länger)	In der Regel eine Nacht im Krankenhaus

3 Erwarteter Nutzen und Erfolgsaussichten

- Eine besser konturierte Kieferlinie und ein definierterer Winkel zwischen Kiefer und Hals
- Weniger Fülle unter dem Kinn und weniger senkrechte Halsstränge
- Straffung erschlaffter Halshaut und ein jüngeres, frischeres Aussehen

Die meisten geeignet ausgewählten Patienten sind mit dem Ergebnis zufrieden. Der größte Teil der Schwellung klingt in den ersten 4–6 Wochen ab; das endgültige Ergebnis zeigt sich innerhalb von **6–12 Monaten**. Bei Patienten mit schlechter Hautqualität, höherem Alter, starkem Gewichtsverlust oder früheren Halsoperationen kann das Ergebnis begrenzter sein. Bei etwa **5–10 von 100** Patienten kann ein kleiner Korrektureingriff (Nachkorrektur) erforderlich sein.

4 Andere Behandlungsmöglichkeiten

- **Verzicht auf die Operation:** Da es sich um einen ästhetischen Eingriff handelt, haben Sie immer die Möglichkeit, ihn nicht durchführen zu lassen.
- **Alleinige Fettabsaugung am Kinn (submentale Liposuktion):** Kann bei Menschen mit guter Hautelastizität ausreichen, deren Fülle nur durch Fett unter der Haut bedingt ist; tiefes Fett, Muskeln oder Drüsen werden dadurch nicht korrigiert.
- **Fettlösende Injektionen (Deoxycholsäure) oder energiebasierte Geräte (Radiofrequenz, Ultraschall):** Bewirken bei leichter Fülle und Erschlaffung eine begrenzte Verbesserung; meist sind mehrere Sitzungen erforderlich.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Botulinumtoxin zur Abschwächung der Platysmastränge:** Verringert die Stränge vorübergehend (3–4 Monate); Erschlaffung und Fett werden dadurch nicht korrigiert.
- **Ein weniger umfangreiches Halslifting:** Kleinere Operationen, bei denen nur überschüssige Haut entfernt oder nur eine Platysmaplastik durchgeführt wird; ihre Wirkung ist begrenzter.

5 Was geschieht, wenn der Eingriff nicht durchgeführt wird?

Ohne Operation bleibt das derzeitige Erscheinungsbild Ihres Halses bestehen, und das natürliche Altern setzt sich fort. Für Ihre Gesundheit besteht dadurch keine Gefahr.

Sie haben das Recht, den empfohlenen Eingriff abzulehnen, ihn zu verschieben oder eine ärztliche Zweitmeinung einzuholen. Diese Entscheidung hat keinerlei Einfluss auf andere medizinische Leistungen, die Ihnen angeboten werden. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen; bitte beachten Sie jedoch, dass es nach Beginn eines Eingriffs Phasen geben kann, in denen ein Abbruch medizinisch nicht vertretbar wäre.

6 Vorbereitung auf den Eingriff

- Vor der Operation werden Blutuntersuchungen und bei Bedarf ein EKG sowie weitere Untersuchungen durchgeführt; Sie werden von der Narkoseärztin bzw. dem Narkosearzt untersucht.
- **Es ist sehr wichtig, dass Ihr Blutdruck gut eingestellt ist.** Bluthochdruck erhöht das Risiko einer Blutansammlung am Hals (Hämatom) nach der Operation deutlich. Fragen Sie die Narkoseärztin bzw. den Narkosearzt, ob Sie Ihr Blutdruckmedikament auch am Morgen der Operation (mit einem Schluck Wasser) einnehmen sollen.
- In den **6–8 Stunden** vor der Operation dürfen Sie nichts essen und nichts trinken (befolgen Sie die Anweisungen der Narkoseärztin bzw. des Narkosearztes).
- Vermeiden Sie vor der Operation anstrengenden Sport, Sauna und übermäßigen Alkoholkonsum. Tragen Sie am Operationstag kein Make-up, keinen Schmuck und keine Halsketten; bringen Sie ein vorne zu knöpfendes Oberteil mit, das nicht über den Kopf gezogen werden muss.
- Es wird empfohlen, dass in den ersten 24–48 Stunden nach der Operation eine Begleitperson bei Ihnen bleibt.
- Teilen Sie Ihrem Arzt **alle Medikamente** mit, die Sie einnehmen (einschließlich Blutverdünnern, Aspirin, Schmerzmitteln, Medikamenten zur Gewichtsabnahme und Hormonpräparaten), sowie alle **pflanzlichen Mittel und Nahrungsergänzungsmittel** (z. B. Omega-3, Vitamin E, Ginkgo, Knoblauch, Ginseng, Fischöl). Setzen Sie kein Medikament eigenmächtig ohne ärztlichen Rat ab.
- Informieren Sie uns unbedingt über **Allergien**, Blutungs- oder Gerinnungsstörungen, Herz- und Lungenerkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck oder Schilddrüsenerkrankungen, frühere Operationen sowie über Probleme, die Sie bei früheren Narkosen hatten.
- Wenn Sie möglicherweise schwanger sind oder stillen, teilen Sie uns dies bitte vor dem Eingriff mit.
- Rauchen und Nikotinprodukte beeinträchtigen die Wundheilung erheblich. Hören Sie nach Möglichkeit mindestens 2–4 Wochen vor dem Eingriff damit auf und rauchen Sie während der Heilungsphase nicht.

7 Heilungsverlauf: Was Sie erwartet

Erste 24–48 Stunden	Am Hals befinden sich ein Verband und eine Drainage. Sie werden eine Schwellung, ein Spannungsgefühl und Beschwerden beim Schlucken haben; die Schmerzen sind meist leicht bis mäßig. Es ist wichtig, mit erhöhtem Kopf (30–45°) zu schlafen, den Hals nicht übermäßig zu beugen und Blutdruckanstiege zu vermeiden (nicht pressen, einen eventuellen Husten unter Kontrolle halten). Die Drainage wird in der Regel am **1.–2. Tag** entfernt.
1. Woche	Schwellung und Blutergüsse, **falls sie auftreten**, sind in dieser Phase am ausgeprägtesten und beginnen dann abzuklingen. Ein Taubheitsgefühl am Hals und unter dem Kinn ist normal. Die **Halsbandage/der Halsverband** wird nach Anweisung Tag und Nacht getragen. Die Fäden werden am **5.–10. Tag** gezogen.
2.–4. Woche	Die meisten Patienten kehren innerhalb von 10–14 Tagen zur Bürotätigkeit und ins gesellschaftliche Leben zurück. Verhärtungen, ein Gefühl von Unebenheit und Spannung am

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

	Hals können fortbestehen. Anstrengender Sport, Bücken, Heben und Bewegungen, die den Hals belasten, sollten mindestens **3–4 Wochen** vermieden werden.
1.–3. Monat	Restschwellung und Verhärtung nehmen allmählich ab. Das Taubheitsgefühl bessert sich weitgehend. Die Narben können in diesem Zeitraum rosafarben und leicht erhaben sein.
6.–12. Monat	Das endgültige Erscheinungsbild zeigt sich; die Narben verblassen und werden feiner. Wird eine Nachkorrektur für notwendig gehalten, erfolgt sie in der Regel frühestens nach 6 Monaten.

8 Mögliche Risiken und Komplikationen

Wie jeder medizinische Eingriff ist auch dieser Eingriff mit gewissen Risiken verbunden. Im Folgenden sind **zu erwartende vorübergehende Begleiterscheinungen** und **Komplikationen** getrennt aufgeführt und nach ihrer Häufigkeit geordnet. Die angegebenen Zahlen sind **ungefähre** Werte aus der medizinischen Fachliteratur; Ihr persönliches Risiko kann je nach Alter, allgemeinem Gesundheitszustand, Rauchen und früheren Operationen niedriger oder höher sein.

Die allermeisten Komplikationen sind **vorübergehend** und bessern sich bei angemessener Behandlung. Aufgeführt sind auch sehr seltene, aber schwerwiegende Ereignisse; dass sie hier stehen, bedeutet nicht, dass sie bei Ihnen auftreten werden, doch Sie sollten sie kennen, um eine informierte Entscheidung treffen zu können.

Zu erwartende, vorübergehende Begleiterscheinungen (keine Komplikationen – ein normaler Teil der Heilung)

- Schwellung am Hals und unter dem Kinn; Blutergüsse klingen, **falls sie auftreten**, innerhalb von 1–3 Wochen ab
- Vorübergehendes Taubheitsgefühl der Halshaut und um die Ohren
- Spannungsgefühl und Verhärtung am Hals sowie leichte Beschwerden beim Schlucken
- Leichte Schmerzen, Juckreiz und rosafarbene Narben an den Schnittstellen
- In den ersten Wochen tastbare Unebenheiten und Verhärtungen unter der Haut

Häufige Beschwerden (meist vorübergehend oder mit Behandlung rückläufig)

- **Länger anhaltende Schwellung und Verhärtung** — Verhärtungen am Hals und unter dem Kinn können mehrere Monate anhalten; sie bessern sich durch Massage und mit der Zeit.
- **Geringe Asymmetrie und Konturunregelmäßigkeiten** — Leichte Unterschiede zwischen beiden Halsseiten oder kleine Dellen/Erhebungen unter der Haut können bestehen bleiben; die meisten gleichen sich mit der Zeit aus, manche können eine kleine Korrektur erfordern.
- **Serom (Flüssigkeitsansammlung)** — Eine Ansammlung klarer Flüssigkeit unter der Haut; wird meist durch Punktion mit einer Nadel in der Praxis behandelt.
- **Notwendigkeit einer Nachkorrektur** — Bei etwa **5–10 von 100** Patienten kann wegen verbliebener Fülle, Unregelmäßigkeiten oder Narben eine kleine Korrektur erforderlich sein.

Gelegentliche Beschwerden

- **Hämatom (Blutansammlung am Hals)** — Tritt bei etwa **2–5 von 100** Patienten auf; es ist **bei Männern und bei Menschen mit Bluthochdruck** häufiger und tritt meist innerhalb der ersten 24 Stunden auf. Kleine Hämatome können mit einer Nadel entleert werden; bei großen ist eine **Rückkehr in den Operationssaal** erforderlich, um das Blut zu entfernen und die Blutung zu stillen. Ein sich rasch vergrößerndes Hämatom kann **auf die Luftröhre drücken und das Atmen erschweren**; dies erfordert eine Notfallbehandlung. Ein spät erkanntes Hämatom kann die Durchblutung der Haut beeinträchtigen und zu Wund- und Narbenproblemen führen.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Vorübergehende Schwäche der Unterlippenbewegung (Ramus marginalis mandibulae / Ramus colli des Gesichtsnervs)** — Bei etwa **1–10 von 100** Patienten kann eine Seite der Unterlippe beim Lächeln asymmetrisch wirken. Die meisten Fälle beruhen auf einer Dehnung des Nervs oder auf der Schwellung und bilden sich **innerhalb von einigen Wochen bis einigen Monaten** von selbst zurück.
- **Speichelaustritt / Speichelansammlung (Sialozele)** — Bei Patienten, deren Unterkieferspeicheldrüse verkleinert wurde, kann Speichel aus der Drüse austreten und sich unter der Haut ansammeln. Dies klingt meist durch wiederholte Punktion mit einer Nadel, einen Druckverband und bei Bedarf Medikamente ab; selten ist ein weiterer Eingriff erforderlich.
- **Fehlbildung durch übermäßige Gewebeentfernung** — Wird zu viel Fett- oder Drüsengewebe entfernt, können eine Mulde in der Halsmitte, hervortretende Muskeln und ein „skelettiertes" Aussehen entstehen („Kobrahals"-Deformität). Die Korrektur kann eine Eigenfetttransplantation oder eine weitere Operation erfordern; deshalb wird das Gewebe ausgewogen und kontrolliert entfernt.
- **Auffällige oder breite Narben** — Narben unter dem Kinn und hinter den Ohren können sich selten verdicken, verbreitern oder ihre Farbe verändern. Sie können mit Kortisoninjektionen, Silikongel oder einer Narbenkorrektur behandelt werden. Reicht der Schnitt hinter dem Ohr bis zum Haaransatz, kann das Haar entlang der Narbe dünner werden. Werden Schnitte um das Ohrläppchen gesetzt, kann das Ohrläppchen selten nach unten und vorne gezogen wirken; bei Bedarf kann eine kleine Korrektur vorgenommen werden.
- **Länger anhaltendes Taubheitsgefühl** — Ein vermindertes Gefühl am Hals und um das Ohrläppchen kann mehrere Monate anhalten; selten kann es teilweise dauerhaft bleiben.
- **Infektion** — Tritt bei **weniger als 1 bis 2 von 100** Patienten auf. Sie heilt meist mit Antibiotika ab; selten ist eine Eiterentleerung (Drainage) erforderlich.

Seltene oder sehr seltene, aber möglicherweise schwerwiegende Komplikationen

- **Gestörte Hautdurchblutung und Gewebeverlust (Nekrose)** — Insbesondere bei **Raucherinnen und Rauchern**, Menschen mit Diabetes und Patienten, bei denen sich ein Hämatom entwickelt, können ein Aufgehen der Wunde und ein Verlust von Haut an den Wundrändern auftreten. Die Heilung verlängert sich, Verbandswechsel und manchmal eine weitere Operation sind erforderlich, und es kann eine bleibende Narbe zurückbleiben.
- **Dauerhafte Nervenschädigung** — Eine dauerhafte Schwäche der Unterlippenbewegung tritt bei **weniger als 1 von 100** Patienten auf. Sehr selten können die Nerven, die die Zunge bewegen (Nervus hypoglossus) oder die Zunge sensibel versorgen (Nervus lingualis), oder der Nerv, der das Ohrläppchen sensibel versorgt (Nervus auricularis magnus), beeinträchtigt werden.
- **Atemwegsprobleme und Schluckbeschwerden** — In sehr seltenen Fällen kann wegen eines großen Hämatoms oder einer ausgeprägten Schwellung eine notfallmäßige Sicherung der Atemwege mit anschließender Überwachung auf der Intensivstation erforderlich sein. Nach der Korrektur der tiefen Strukturen können vorübergehend Schluckbeschwerden auftreten.
- **Verletzung eines Blutgefäßes oder eines Speichelgangs** — Blutungen durch eine Verletzung der Halsvenen oder Probleme mit dem Ausführungsgang der Speicheldrüse sind sehr selten; sie können eine weitere Behandlung oder einen Eingriff erforderlich machen.
- **Erneute Erschlaffung** — Im Laufe der Jahre kann der Hals durch das Altern und Gewichtsveränderungen wieder erschlaffen; dies ist ein natürlicher Vorgang und keine Komplikation. Auch die Halsstränge können mit der Zeit wieder sichtbar werden. Eine deutliche frühe Erschlaffung ist selten.
- **Psychische Unzufriedenheit** — Trotz eines technisch erfolgreichen Ergebnisses kann es einem Menschen schwerfallen, sich an sein neues Aussehen zu gewöhnen. Ein offenes Gespräch über die Erwartungen vor der Operation verringert dieses Risiko.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Allgemeine Risiken jedes operativen / medizinischen Eingriffs

- **Narkoserisiken:** Wird eine Vollnarkose oder Sedierung (Dämmerschlaf) durchgeführt, erläutert Ihnen der Narkosearzt deren Risiken (Übelkeit, Halsschmerzen, Zahnschäden, allergische Reaktion und sehr selten Herz- oder Lungenprobleme) gesondert, und Ihre Einwilligung wird auf einem **separaten Narkose-Aufklärungsbogen** eingeholt.
- **Blutung und Bluttransfusion:** Eine Bluttransfusion ist bei diesen Eingriffen nur sehr selten erforderlich. Bei einer schweren Blutung können Blut oder Blutprodukte notwendig werden; diese bergen eigene, sehr seltene Risiken (z. B. Allergie oder Infektion).
- **Infektion:** Eine Wundinfektion nach der Operation wird in der Regel mit Antibiotika behandelt; selten kann eine Drainage (Ableiten des Eiters) notwendig sein.
- **Blutgerinnsel in den Beinvenen (Thrombose) und in der Lunge (Lungenembolie):** Bei kurzen Operationen im Kopf-Hals-Bereich sehr selten. Frühes Aufstehen und Gehen senkt das Risiko. Hormonpräparate, Rauchen, starkes Übergewicht und frühere Blutgerinnsel erhöhen das Risiko.
- **Medikamentenallergie:** Auf die verwendeten Medikamente, Desinfektionsmittel, Pflaster oder Nahtmaterialien kann eine allergische Reaktion auftreten.
- **Narbenbildung und Heilungsstörungen:** Wie Narben verheilen, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich; sehr selten kann sich eine verdickte (hypertrophe) Narbe oder ein Keloid bilden.
- **Lebensgefahr:** Todesfälle bei geplanten Operationen im Kopf-Hals-Bereich sind heute äußerst selten; dennoch ist kein operativer Eingriff völlig frei von Risiken. Eine schwere Komplikation kann eine Behandlung auf der Intensivstation erforderlich machen und zu einer bleibenden Behinderung führen.

Diese Aufstellung umfasst nicht jede denkbare Komplikation; andere unvorhersehbare und sehr seltene Ereignisse können auftreten. Tritt eine Komplikation auf, plant Ihr Arzt die notwendige Behandlung und Nachsorge; dies kann eine zusätzliche Behandlung, Medikamente, Eingriffe oder eine erneute Operation erfordern.

9 Wann Sie sich sofort bei uns melden sollten

- **Rasch zunehmende Schwellung, Spannung oder deutliche einseitige Vergrößerung** des Halses, besonders in den ersten 24–48 Stunden
- **Atembeschwerden, eine Veränderung Ihrer Stimme, Unfähigkeit zu schlucken** oder Erstickungsgefühl (rufen Sie unverzüglich die 112 an)
- **Nicht aufhörende Blutung** unter dem Verband oder rasch zunehmendes Blut in der Drainageflasche
- **Fieber über 38,5 °C**, zunehmende Rötung, Schmerzen, Überwärmung oder Eiter an den Schnittstellen
- **Dunkelfärbung, violett-schwarze Verfärbung** der Haut oder Aufgehen der Wunde
- Plötzliche starke Schmerzen oder Schmerzen, die auf Schmerzmittel nicht ansprechen
- Atemnot, Brustschmerzen oder einseitige Schwellung und Schmerzen in einem Bein

Wenn eines dieser Anzeichen auftritt, rufen Sie unverzüglich Ihren Arzt an: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Wenn Sie uns nicht erreichen, suchen Sie die nächste Notaufnahme auf oder wählen Sie die 112 (Notrufnummer in der Türkei und in ganz Europa).

10 Hinweise zu Medikamenten und zum Alltag

- Schlafen Sie in den ersten 2 Wochen auf dem Rücken mit erhöhtem Kopf; vermeiden Sie übermäßiges Beugen des Halses, plötzliche Kopf- und Halsbewegungen sowie Vorbeugen.
- Tragen Sie die Halsbandage/den Halsverband für den empfohlenen Zeitraum (in der Regel 1–3 Wochen).
- Messen Sie regelmäßig Ihren Blutdruck und lassen Sie keine Medikamenteneinnahme aus; vermeiden Sie Pressen, schweres Heben und unkontrolliertes Husten.
- Vermeiden Sie in den ersten 3–4 Wochen anstrengenden Sport, Sauna, Hamam (Dampfbad) und heiße Duschen.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Schützen Sie Ihre Narben mindestens 3–6 Monate lang vor der Sonne.
- Wenn Sie aus dem Ausland angereist sind, ist eine Flugreise in der Regel unbedenklich, sobald die Drainage entfernt und die ersten Kontrollen abgeschlossen sind, meist ab dem 5.–7. Tag.
- Nehmen Sie die Ihnen verordneten Medikamente (Antibiotika, Schmerzmittel usw.) in der empfohlenen Dosierung und für die empfohlene Dauer ein. Nehmen Sie Aspirin oder ähnliche Medikamente, die Blutungen verstärken können, nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt ein.
- Trinken Sie nach der Operation bei Flügen oder Reisen von mehr als 4 Stunden reichlich Wasser, bewegen Sie sich regelmäßig und tragen Sie, falls empfohlen, Kompressionsstrümpfe; dies senkt das Risiko von Blutgerinnseln in den Beinen.
- Während der Heilungsphase wird empfohlen, keinen Alkohol zu trinken und auf Rauchen und Nikotinprodukte zu verzichten.
- Bitte nehmen Sie alle Kontrolltermine wahr. Wenn Sie aus dem Ausland angereist sind, kann die Nachsorge nach Ihrer Rückkehr per Online-Sprechstunde und Fotos/Videos fortgeführt werden; falls Sie einen Arzt vor Ort aufsuchen müssen, erhalten Sie einen schriftlichen Operationsbericht und unsere Empfehlungen.

11 Unerwartete Befunde während des Eingriffs, Gewebeproben und Blutprodukte

Ergibt sich während des Eingriffs eine unvorhergesehene Situation, hält sich Ihr Arzt an den Umfang des Eingriffs, in den Sie mit diesem Bogen eingewilligt haben. **Sofern keine Lebensgefahr und keine Gefahr eines schweren Organschadens besteht**, wird kein zusätzlicher Eingriff vorgenommen, in den Sie nicht eingewilligt haben; in diesem Fall wird der Eingriff an einem sicheren Punkt beendet, und Sie werden anschließend informiert, damit die Entscheidung gemeinsam mit Ihnen getroffen werden kann. Besteht Lebensgefahr, wird die Notfallbehandlung durchgeführt, die zum Schutz Ihres Lebens oder des Organs erforderlich ist.

Während des Eingriffs entnommenes Gewebe wird, wenn nötig, zur Sicherung der Diagnose zur **feingeweblichen (pathologischen) Untersuchung** eingesandt. Je nach Ergebnis kann eine weitere Behandlung oder Nachsorge erforderlich sein.

Eine Bluttransfusion ist bei diesen Eingriffen nur sehr selten notwendig und wird nur verabreicht, wenn sie lebenswichtig ist. Wenn Sie Blut oder Blutprodukte ablehnen (zum Beispiel aus religiösen Gründen), müssen Sie uns dies vor dem Eingriff mitteilen; die möglichen Folgen dieser Entscheidung werden gesondert mit Ihnen besprochen und unter „Informationen speziell für Sie“ festgehalten.

12 Fotos, Bildaufnahmen und Ihre personenbezogenen Daten

Vor und nach dem Eingriff können zur Planung, Verlaufskontrolle und Beurteilung des Ergebnisses **Fotos/Videos** angefertigt werden. Diese Aufnahmen sind Teil Ihrer Krankenakte und werden vertraulich behandelt. Ihre Aufnahmen werden **niemals für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit oder soziale Medien verwendet.**

Für jeden anderen Zweck dürfen Ihre Aufnahmen **nur mit Ihrer gesonderten und ausdrücklichen Erlaubnis** verwendet werden. Eine Ablehnung hat keinerlei Einfluss auf Ihre Behandlung, und Sie können Ihre Erlaubnis jederzeit widerrufen:

☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine Aufnahmen **ausschließlich für die medizinische Dokumentation und die Verlaufskontrolle der Behandlung** verwendet werden.

☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich nicht erkennbar bin** (Gesicht/Augenpartie abgedeckt).

☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich erkennbar sein kann**.

☐ Ich **erlaube keine** Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken / Ausbildungszwecken.

Ihre personenbezogenen Daten und Gesundheitsdaten werden nach dem türkischen Gesetz Nr. 6698 zum Schutz personenbezogener Daten (KVKK) und den einschlägigen gesundheitsrechtlichen Vorschriften zu Zwecken der Diagnose, der Behandlung und der Erfüllung gesetzlicher Pflichten von Personen verarbeitet, die der beruflichen Schweigepflicht unterliegen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren Datenschutzhinweisen.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

13 Informationen und Anmerkungen speziell für Sie (vom Arzt auszufüllen)

Patientenspezifische zusätzliche Risiken (Begleiterkrankungen, Medikamente, frühere Operationen), Einzelheiten der Planung, Erwartungen der Patientin / des Patienten, gestellte Fragen und gegebene Antworten. Gibt es nichts zu ergänzen, „keine" eintragen.

14 Erklärung der Patientin / des Patienten

- ☐ Ich habe diesen Bogen in meiner Sprache gelesen und verstanden. Ich hatte ausreichend Bedenkzeit, konnte Fragen stellen und habe zufriedenstellende Antworten erhalten.
- ☐ Meine Erkrankung, das Ziel des empfohlenen Eingriffs, wie, von wem und wo er durchgeführt wird, seine voraussichtliche Dauer, der erwartete Nutzen, die Erfolgsaussichten, die Alternativen und die möglichen Folgen, wenn er nicht durchgeführt wird, wurden mir mündlich und schriftlich erklärt.
- ☐ Die häufigen und die möglicherweise schwerwiegenden Risiken sowie die möglichen Folgen dieser Komplikationen (einschließlich der Möglichkeit, dass eine weitere Behandlung oder ein erneuter Eingriff bzw. eine erneute Operation notwendig wird) wurden mir erklärt. Mir ist bewusst, dass das Ergebnis eines medizinischen Eingriffs **nicht zu 100 % garantiert werden kann**.
- ☐ Ich habe zutreffende und vollständige Angaben zu meinem Gesundheitszustand, meinen Medikamenten, meinen Allergien und früheren Erkrankungen gemacht. Mir ist bewusst, dass unvollständige oder falsche Angaben die Risiken erhöhen können.
- ☐ Mir ist bewusst, dass die Befolgung der Anweisungen vor und nach dem Eingriff zum Ergebnis beiträgt und dass die Wahrnehmung der Kontrolltermine wichtig ist.
- ☐ Ich weiß, dass ich meine Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen kann. Mir ist bewusst, dass meine Unterschrift unter diesen Bogen den Arzt nicht von seiner Sorgfaltspflicht entbindet.
- ☐ Ich treffe diese Entscheidung aus freiem Willen und ohne Druck von irgendeiner Seite.
- ☐ Ich habe verstanden, dass die Operation das Altern nicht aufhält, dass der Hals mit der Zeit wieder erschlaffen kann und dass das Ergebnis durch meine Hautqualität, mein Gewicht und meinen Knochenbau begrenzt ist.
- ☐ Ich habe verstanden, dass es wichtig ist, meinen Blutdruck unter Kontrolle zu halten und die Anweisungen nach der Operation zu befolgen, um das Risiko einer Blutung (Hämatom) zu verringern.
- ☐ Mir ist bewusst, dass dieser Eingriff **ästhetischer Natur** ist, dass er medizinisch nicht notwendig ist und dass ich jederzeit die Möglichkeit habe, ihn nicht durchführen zu lassen. Ich habe meine Erwartungen mit meinem Arzt besprochen, und das realistisch erreichbare Ergebnis wurde mir erklärt.
- ☐ Mir ist bewusst, dass weder eine vollkommene Symmetrie noch eine exakte Nachbildung des Aussehens auf einem Foto garantiert werden kann, dass das endgültige Ergebnis davon abhängt, wie mein Gewebe heilt, und dass in manchen Fällen ein Korrektureingriff notwendig sein kann.

- ☐ **Ich ERTEILE MEINE EINWILLIGUNG zu dem oben beschriebenen Eingriff.**
- ☐ **Den oben beschriebenen Eingriff LEHNE ICH AB. Die möglichen Folgen der Ablehnung wurden mir erklärt.**

Wir empfehlen, dass die Patientin / der Patient handschriftlich ergänzt: „Ich habe diesen Bogen gelesen und verstanden und willige ein."

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

15 Unterschriften

	VOR- UND NACHNAME	UNTERSCHRIFT	DATUM / UHRZEIT
Patient/in			
Gesetzliche/r Vertreter/in (Elternteil / Vormund) – Verhältnis zum Patienten:			
Aufklärender und durchführender Arzt			
Dolmetscher/in (falls erforderlich) – Sprache:			
Zeuge/Zeugin (falls erforderlich)			

Erklärung der Dolmetscherin / des Dolmetschers: Ich habe diesen Bogen und die mündlichen Erläuterungen des Arztes der Patientin / dem Patienten bzw. der gesetzlichen Vertretung vollständig und korrekt in eine für sie verständliche Sprache übersetzt.

FÜR PATIENTINNEN UND PATIENTEN UNTER 18 JAHREN ODER MIT EINGESCHRÄNKTER EINWILLIGUNGSFÄHIGKEIT

Bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren wird die Einwilligung von einem **Elternteil oder dem gesetzlichen Vormund** erteilt. Das Kind wird seinem Alter und seiner Reife entsprechend aufgeklärt, und seine Meinung wird eingeholt. Bei nicht einwilligungsfähigen Patientinnen und Patienten erteilt die gesetzliche Vertretung die Einwilligung.

☐ Sofern wir das Sorgerecht gemeinsam ausüben, erkläre ich, dass der andere Elternteil über diesen Eingriff informiert ist und ihm zustimmt.

☐ Ich erkläre, dass keine gerichtliche Entscheidung und kein Streit über das Sorgerecht / die Vormundschaft besteht (falls doch, wurde dem Arzt das entsprechende Dokument vorgelegt).

Das Kind wurde altersgerecht aufgeklärt; Meinung des Kindes: _____

Dieser Bogen wurde in zwei Exemplaren ausgefertigt: Ein Exemplar verbleibt in der Patientenakte, eines erhält die Patientin / der Patient bzw. die gesetzliche Vertretung.

WIDERRUF DER EINWILLIGUNG (NUR AUSFÜLLEN, WENN SIE SICH ANDERS ENTSCHEIDEN)

Ich widerrufe die oben erteilte Einwilligung. Die möglichen Folgen des Widerrufs wurden mir erklärt.

Name, Unterschrift, Datum und Uhrzeit der widerrufenden Person (Patient/in bzw. Vertreter/in): _____

Dieser Bogen wurde in Übereinstimmung mit der türkischen Patientenrechteverordnung und den Grundsätzen der Türkischen Ärztekammer zur Aufklärung und Einwilligung erstellt. Er ergänzt das mündliche Aufklärungsgespräch mit Ihrem Arzt, ersetzt es aber nicht.